

TEMA 2.9 • TRAUMATOLOGÍA

Lesiones de Rodilla

PERFIL EUNACOM 8.01.1.003
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

La **fractura de cadera** es una patología crítica en la práctica clínica, situada en la intersección de la traumatología y la geriatría. Representa una de las principales causas de morbilidad en el adulto mayor; se estima que la mortalidad a los dos años de ocurrida la fractura alcanza el **50%**. Por ello, su enfoque no solo es quirúrgico, sino también preventivo y rehabilitador.

Epidemiología y Factores de Riesgo

La fractura de cadera es considerada una **fractura osteoporótica** por excelencia.

- **En adultos mayores:** El mecanismo habitual es un trauma de baja energía, como una **caída de propia altura** (tropezón o resbalón) sobre el costado del cuerpo. El sustrato fisiopatológico es la **Osteoporosis**.
- **En pacientes jóvenes:** Se requiere un trauma de **muy alto impacto** (accidentes de tránsito, caídas de gran altura) para fracturar el fémur proximal.

Clínica y Examen Físico

El diagnóstico clínico es altamente sugerente basándose en la anamnesis y la inspección. Los signos cardinales incluyen:

- **Antecedente de caída:** Incapacidad inmediata para levantarse o deambular.
- **Imposibilidad de elevar el talón:** El paciente no puede despegar el talón de la cama/piso.
- **Posición Impúdica:** Es la presentación clásica de la extremidad afectada.

La "Posición Impúdica"

Se caracteriza por tres elementos clave: - **Abducción:** La pierna se aleja de la línea media. - **Rotación externa:** El pie "mira" hacia afuera. - **Acortamiento:** La extremidad se ve más corta que la contralateral debido al desplazamiento óseo.

PERLA CLÍNICA EUNACOM

Mnemotecnia: Para recordar la **Posición Impúdica** de la fractura, piensa que el paciente "no tiene pudor" y muestra la zona inguinal al rotar la pierna hacia afuera. En cambio, la **Luxación Posterior** tiene posición **Púdica** (aducción y rotación interna, como "escondiéndose").

Diagnóstico por Imágenes

El estudio debe ser sistemático para clasificar la fractura y planificar la cirugía:

- **Radiografía de Pelvis AP:** Permite comparar ambas caderas y descartar fracturas asociadas en el lado contralateral.
- **Radiografía de Cadera AP y Axial:** Son las proyecciones específicas para evaluar el rasgo de fractura en el fémur proximal.

Clasificación y Manejo Quirúrgico

El tratamiento de la fractura de cadera es **siempre quirúrgico**, salvo en casos de riesgo vital inminente que contraindique la anestesia.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

Antes de operar, se debe aplicar el **ABC de la reanimación**. Si el paciente presenta inestabilidad hemodinámica, shock, infección activa o **Delirium** descompensado, se debe **estabilizar primero** y operar en una segunda instancia una vez que el paciente esté compensado.

Tipos de Cirugía según el rasgo de fractura

TABLA 2.9.1: TIPO DE FRACTURA VS TRATAMIENTO DE ELECCIÓN		
TIPO DE FRACTURA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN	CONSIDERACIONES
Intertrocantérica	Osteosíntesis con DHS (Dynamic Hip Screw)	El riesgo de necrosis es bajo porque la irrigación suele mantenerse indemne.
De Cuello Femoral	Tornillos Canulados u Osteosíntesis	Se prefiere en pacientes jóvenes o fracturas no desplazadas.
De Cuello Femoral (Criterios específicos)	Prótesis de Cadera	Se usa cuando el riesgo de necrosis es muy alto.

Criterios para indicar Prótesis de entrada

Se prefiere la prótesis (reemplazo articular) en lugar de fijar el hueso cuando se cumplen simultáneamente estas tres condiciones:

1. Fractura de **cuello femoral** (intracapsular). 2. Fractura **desplazada**. 3. Paciente **mayor de 65 años**.

NOTA CLÍNICA

Fisiopatología de la Necrosis: La irrigación de la cabeza femoral depende principalmente de las arterias circunflejas que rodean el cuello. Una fractura de cuello desplazada rompe estos vasos, provocando una **necrosis avascular de la cabeza femoral**, la complicación más frecuente y grave de este tipo de fracturas.

Procedimiento de Girdlestone

Es una cirugía de salvataje o paliativa para pacientes **postrados crónicos**. - **En qué consiste:** Se retira la cabeza femoral y se descarta, dejando al paciente sin articulación ("cadera flotante"). - **Objetivo:** Eliminar el dolor causado por el roce de los fragmentos óseos para evitar complicaciones como el **Delirium** o infecciones, sin la necesidad de implantes caros en alguien que ya no camina.

Diagnóstico Diferencial: Luxación Posterior de Cadera

Es fundamental no confundirla con la fractura, aunque el cuadro clínico tiene diferencias marcadas.

- **Mecanismo:** Típicamente el "accidente del copiloto" (impacto de la rodilla contra el tablero del auto) o caídas de altura.
- **Clínica (Posición Púdica):**
 - - **Aducción** (pierna hacia adentro).
 - - **Rotación interna**.
 - - **Acortamiento**.
- **Complicación asociada:** Alta frecuencia de lesión del **nervio ciático** (siempre evaluar sensibilidad y motilidad distal).
- **Tratamiento:** Reducción cerrada bajo anestesia en pabellón, seguida de inmovilización.

Resumen comparativo de posiciones

TABLA 2.9.2: HALLAZGO VS FRACTURA DE CADERA		
HALLAZGO	FRACTURA DE CADERA	LUXACIÓN POSTERIOR
Posición	Impúdica	Púdica
Rotación	Externa	Interna
Aducción/Abducción	Abducción	Aducción
Acortamiento	Presente	Presente

Seguimiento y Prevención

- Dado que es una fractura por fragilidad, el manejo postoperatorio debe incluir:
- Rehabilitación kinésica precoz (idealmente levantarse al día siguiente).
- Manejo de la **Osteoporosis** (Calcio, Vitamina D, bisfosfonatos).
- Evaluación del riesgo de **Caídas en el Adulto Mayor**.
- Prevención de complicaciones del decúbito (escaras, neumonías, trombosis venosa profunda).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. ¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Lesiones de Rodilla. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Todas las lesiones de rodilla meniscales y ligamentosas se diagnostican con resonancia magnética nuclear porque no se ven en la radiografía.
- La lesión de menisco se reconoce por bloqueo articular e inestabilidad; la maniobra de Apley diagnostica qué menisco está afectado según la rotación dolorosa.
- El cajón anterior indica rotura del ligamento cruzado anterior que siempre requiere cirugía artroscópica.
- El cajón posterior indica rotura del ligamento cruzado posterior que habitualmente se trata conservadoramente.
- Los ligamentos colaterales se lesionan por valgo o varo forzado; el signo de bostezo los evalúa; el tratamiento es conservador con inmovilizador.
- El colateral medial puede asociarse a lesión del menisco interno; el lateral es extracapsular y habitualmente no afecta el menisco.
- La disfunción patelofemoral produce dolor anterior de rodilla con actividad y se trata con fortalecimiento del cuádriceps.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (LESIONES DE RODILLA)

PREGUNTA 1

Un paciente relata que al caminar siente que su rodilla se queda atascada y le duele. Al examen con la maniobra de Apley, le duele al rotar en rotación externa. ¿Cuál es el diagnóstico y el examen de elección?

- A) Lesión del menisco externo; radiografía de rodilla
- B) Lesión del menisco interno; resonancia magnética nuclear
- C) Rotura del ligamento cruzado anterior; resonancia magnética
- D) Lesión del menisco interno; radiografía de rodilla en dos proyecciones
- E) Disfunción patelofemoral; solo reposo y AINEs

PREGUNTA 2

Un futbolista sufre un mecanismo de hiperextensión de rodilla y presenta inestabilidad y cajón anterior positivo. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Rotura del ligamento cruzado posterior; tratamiento conservador
- B) Rotura del ligamento cruzado anterior; cirugía artroscópica
- C) Rotura del ligamento cruzado anterior; tratamiento conservador con reposo y AINEs
- D) Lesión de menisco interno; maniobra de Apley para confirmar
- E) Esguince de ligamento colateral lateral; inmovilizador de rodilla

PREGUNTA 3

Un paciente sufre un mecanismo de valgo forzado de rodilla y presenta dolor e inestabilidad medial con signo de bostezo al valgo positivo. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento?

- A) Lesión del ligamento colateral lateral; cirugía artroscópica
- B) Rotura del ligamento cruzado posterior; inmovilizador
- C) Lesión del ligamento colateral medial; inmovilizador de rodilla
- D) Lesión del ligamento colateral medial; cirugía artroscópica de urgencia
- E) Lesión de menisco externo; maniobra de Apley y resonancia magnética

RESUMEN: LESIONES DE RODILLA

Las lesiones de rodilla más importantes para el EUNACOM incluyen las lesiones meniscales, las lesiones de los ligamentos cruzados anterior y posterior, y las lesiones de los ligamentos colaterales. Todas ellas tienen en común que producen dolor e impotencia funcional, y que el diagnóstico se hace con resonancia magnética nuclear porque meniscos y ligamentos son tejido blando no visible en la radiografía. La lesión de menisco se reconoce por el bloqueo articular, la sensación de que la rodilla se queda atascada al caminar, más inestabilidad y dolor en la interlínea articular. El diagnóstico se confirma con la maniobra de Apley: el paciente en decúbito prono con rodilla en noventa grados, se comprime el pie hacia la camilla y se rota; el talón apunta al menisco afectado. Si duele con rotación externa está lesionado el menisco interno; si duele con rotación interna está lesionado el menisco externo. El tratamiento inicial es conservador con reposo, AINEs y fortalecimiento del cuádriceps; la cirugía artroscópica está indicada cuando falla el tratamiento conservador. Las lesiones de los ligamentos cruzados se reconocen por la inestabilidad y el signo del cajón: cajón anterior indica rotura del ligamento cruzado anterior; cajón posterior indica rotura del posterior. El cruzado anterior siempre se opera artroscópicamente. El cruzado posterior habitualmente se trata de forma conservadora excepto si hay inestabilidad persistente o el paciente es deportista. Los ligamentos colaterales medial y lateral se lesionan por valgo o varo forzado respectivamente; se evalúan con el signo de bostezo y habitualmente se tratan de forma conservadora con inmovilizador de rodilla. La disfunción patelofemoral tiene dolor anterior de rodilla con actividad y se trata con fortalecimiento del cuádriceps.